



SCIENTIA Jurnal Farmasi dan Kesehatan

Diterbitkan oleh Universitas Perintis Indonesia setiap bulan Februari dan Agustus

Website : <http://www.jurnalscientia.org/index.php/scientia>

11 (1) ; 36-41, 2021

Hubungan Kesesuaian Peresepan Obat Dan Kendali Biaya Berdasarkan Formularium Nasional Pasien BPJS Di RSUD Ungaran Kabupaten Semarang

Ferika Indrasari*, Sri Suwarni, Rani Kurniawati

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

*email: ferikaindrasari89@gmail.com

Diterima : 22-01-2021 ; Direvisi : 10-02-2021; Diterbitkan : 19-02-2021

ABSTRAK

Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan utama pengaturan obat dalam Formularium Nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan dan efektifitas pengobatan sehingga tercapai penggunaan obat rasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kesesuaian peresepan obat dan kendali biaya berdasarkan Formularium Nasional pada pasien BPJS di RSUD Ungaran Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian analitik kuantitatif dengan desain penelitian secara retrospektif. Teknik pengambilan data menggunakan *random sampling*. Data peresepan obat pasien BPJS Rawat Jalan diperoleh dari resep periode Oktober – Desember 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kesesuaian peresepan obat berdasarkan Formularium Nasional 77,96% artinya belum sesuai dengan indikator kesesuaian peresepan berdasarkan formularium 100%. Besarnya selisih biaya obat di luar Formularium Nasional rata-rata 41,38% setiap bulannya. Hubungan yang bermakna antara kesesuaian peresepan obat berdasarkan Formularium Nasional dan selisih biaya obat dengan nilai Sig.(2-tailed) 0,000 ($p < 0,050$). Sehingga perlu adanya upaya sosialisasi yang berkesinambungan kepada *prescriber* bahwa Formularium Nasional sebagai pedoman pengobatan untuk pasien BPJS dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pengendalian biaya obat.

Kata Kunci : Peresepan Obat, Kendali Biaya, Formularium Nasional

ABSTRACT

The National Formulary is a list of selected drugs needed and available at health care facilities as a reference in implementing the National Health Insurance. The main objective of drug regulation in the National Formulary is to improve the degree of health through increased and effective treatment so that rational drug use is achieved. This study aims to determine the relationship between the suitability of drug prescribing and cost control based on the National Formulary for BPJS patients at Ungaran Hospital, Semarang Regency. This research is a quantitative analytic study with a retrospective research design. The data collection technique used random sampling. Data for prescribing drugs for outpatient BPJS patients were obtained from prescriptions for the period October - December 2018. The results showed that the suitability level of prescribing drugs based on the National Formulary was 77.96%, meaning that it was not following the indicator of the suitability of prescription based on formulary 100%. The amount of difference in drug costs outside the National Formulary averages 41.38% per month. The significant relationship between the suitability of drug prescription based on the National Formulary and the difference in drug costs with a Sig. (2-tailed) value of 0.000 ($p < 0.050$). So there is a need for continuous socialization efforts to the prescriber that the National Formulary is a treatment guide for BPJS patients in improving service quality and controlling drug costs.

Keywords: Drug prescribing, cost control, National Formulary.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyatakan bahwa pelayanan farmasi Rumah Sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi lapisan masyarakat. Badan pemerintah yang ikut serta membantu dalam penyediaan pelayanan kefarmasian, salah satunya adalah BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014 (Depkes RI, 2016).

Peresepan obat pasien BPJS diatur dalam Formularium Nasional. Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan jaminan kesehatan Republik Indonesia (Dirjen Binfar dan Alkes, 2014). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyatakan bahwa penulisan resep seluruhnya harus mengacu pada Formularium Nasional dengan standar 100%. Obat yang dibutuhkan tetapi tidak tercantum dalam Formularium Nasional dapat digunakan atas persetujuan Direktur dan Komite Medik. Manfaat Formularium Nasional adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mengendalikan biaya pengobatan terutama pada pasien BPJS (Depkes RI, 2008).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ragil Prasetyo (2015) menunjukkan bahwa analisis kesesuaian peresepan dengan Formularium Nasional pada pasien Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan indikator peresepan WHO 1993 bahwa kesesuaian peresepan obat dengan Formularium Nasional adalah 61,67 % dimana $< 100\%$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi polifarmasi. Rata-rata jumlah item obat per lembar resep terbaik adalah 1,8 – 2,2 item per lembar resep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata item per lembar resep adalah 3,2. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peresepan obat masih menggunakan obat di luar

Formularium Nasional dan terjadi polifarmasi. Semakin tinggi prosentase kesesuaian penulisan resep sesuai dengan Formularium Nasional biaya obat akan lebih efisien (WHO, 1993).

Dalam penyelenggaraan kefarmasian memerlukan suatu pantauan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan pengendalian biaya obat. Penulisan resep di luar Formularium Nasional menyebabkan biaya obat yang lebih besar dari peresepan obat sesuai Formularium Nasional. Pentingnya peresepan obat sesuai dengan Formularium Nasional sangat berpengaruh pada efisiensi biaya obat Pasien BPJS (PerMenKes, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul “Hubungan kesesuaian peresepan obat dan kendali biaya berdasarkan Formularium Nasional pada pasien BPJS Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran” untuk memberikan gambaran tentang pentingnya peresepan obat sesuai dengan Formularium Nasional agar biaya obat menjadi lebih efisien.

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik kuantitatif dengan desain penelitian secara retrospektif. Penelitian ini menganalisa tentang kesesuaian peresepan obat berdasarkan Formularium Nasional dan hubungan terhadap kendali biaya. Pengambilan data retrospektif dan data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dari survei resep pasien BPJS Rawat Jalan

2. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh resep pasien BPJS instalasi rawat jalan di RSUD Ungaran Kabupaten Semarang selama periode Oktober – Desember 2018.

3. Sampel

Besarnya sampel dihitung menggunakan rumus *Slovin*. Jumlah sampel yang didapatkan adalah 391 yang dibulatkan menjadi 400 sampel yang terbagi menjadi 3 bulan pelayanan yang diambil secara *random*. Besarnya sampel 400 lembar.

4. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling* dimana populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat dijadikan sampel. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *random*

sampling.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi dan pedoman wawancara beserta rincian biaya pasien BPJS Rawat Jalan pada periode Oktober sampai Desember 2018.

6. Analisis Data

a. Uji Univariat

Uji univariat adalah uji yang dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya analisa ini hanya menghasilkan distribusi dari tiap variabel (Notoatmojo, 2012).

$$p = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

p : Prosentase

n : Jumlah sampel yang mendapatkan per kategori

N : Jumlah total sampel

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit menyatakan bahwa standar kesesuaian penulisan resep adalah 100%. Rumah Sakit melaporkan persentase (%) kesesuaian obat dengan Fornas kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota menggunakan :

$$\% \text{ Kesesuaian} = \frac{\text{jumlah item obat di RS yang sesuai dengan Fornas}}{\text{Jumlah item obat yang tersedia di RS}} \times 100\%$$

b. Uji Bivariat

Uji bivariat adalah uji yang dilakukan menggunakan metode analisa Metode analisa yang digunakan adalah analisis korelasi menggunakan metode *Spearman*. Menurut Sugiyono (2017) metode analisa korelasi *Spearman* merupakan metode analisa yang digunakan untuk mencari hubungan atau signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Apabila nilai variabel independen mengalami penurunan dan kenaikan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio dan ordinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pasien

Pada penelitian ini pembagian rentang usia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang rencana Aksi Kesehatan Lanjut Usia pada tahun 2016 – 2019. Pembagian rentang usia menurut Peraturan Menteri Kesehatan adalah 0 sampai dengan > 60 tahun. Pada penelitian ini pasien BPJS Rawat Jalan tercatat jumlah pasien terbanyak pada rentang usia 19 – 45 tahun sebanyak 68 pasien (22,7%), rentang usia 46 – 59 tahun sebanyak 90 pasien (30,7%) dan rentang usia di atas 60 tahun sebanyak 116 pasien (38,7%), dikarenakan dengan bertambahnya usia, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses degeneratif (penuaan) yang menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan

Tabel 1. Karakteristik Pasien BPJS Rawat Jalan

	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin:		
L (laki - laki)	182	45,5%
P(Perempuan)	218	54,5%
Usia :		
0-1	4	1%
2-6	12	3%
7-18	17	4,25%
19-45	92	23%
46-59	120	30%
>60	155	38,75%

2. Peresepan Obat Pasien BPJS Rawat Jalan di RSUD Ungaran

Peresepan obat adalah resep yang ditulis oleh dokter penanggung jawab pasien untuk pasien BPJS di poliklinik Rawat Jalan di RSUD Ungaran. Pada penelitian ini menggunakan sampel resep pasien BPJS rawat jalan di Instalasi Farmasi RSUD Ungaran yang berjumlah 400 lembar resep. Dengan perincian data seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Peresepan Obat Pasien BPJS Rawat Jalan

Bulan	Sampel Lembar Resep	Jumlah Resep
Oktober	134	452
Nopember	125	483
Desember	141	443
Total	400	1378

Dari data tersebut dari 400 lembar resep terdapat 1378 peresepan obat yang terdistribusi selama tiga bulan pelayanan, bulan Oktober sampai dengan Desember 2018. Jumlah lembar

resep terbanyak 141 lembar pada pelayanan bulan Desember sedangkan jumlah peresepan obat terbanyak dengan jumlah 452 peresepan pada bulan Oktober.

3. Analisa Univariat

a. Tingkat Kesesuaian Peresepan Obat Berdasarkan Formularium Nasional.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit untuk pelayanan kefarmasian salah satu diantaranya adalah kesesuaian peresepan obat berdasarkan Formularium adalah 100%. Dari data yang digunakan dalam perhitungan prosentase obat di dapatkan dari seluruh item obat yang di gunakan dalam peresepan setiap bulannya. Hasil prosentase yang didapatkan antara rentang antara 72%-79%. Prosentase kesesuaian tertinggi pada bulan Oktober 2018 yaitu 78,76% sedangkan kesesuaian terendah 72,00% pada bulan Desember. Hasil rata-rata kesesuaian peresepan obat berdasarkan Formularium Nasional selama bulan Oktober-Desember 2018 sebesar 74,48%. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit untuk Pelayanan Kefarmasian yang memberikan indikator kesesuaian peresepan obat berdasarkan Formularium Nasional adalah 100%, hasil prosentase tersebut belum sesuai.

Tabel 3. Tingkat Kesesuaian Peresepan Obat Pasien BPJS Rawat Jalan dengan Formularium

No	Bulan	Item Obat	Item Fornas	Item Non Fornas	Prosentase Kesesuaian Peresepan
1	Oktober	452	356	96	78,76%
2	Nopember	483	351	132	72,67%
3	Desember	443	319	124	72,00 %
Rata - rata					74,48%

Sumber : Data primer yang diolah

Ketidaksesuaian peresepan obat berdasarkan Formularium Nasional disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman bahwa pelayanan resep pasien BPJS mengacu pada Formularium Nasional. Selain itu adanya faktor medis di mana keadaan darurat pasien tidak mungkin menggunakan obat sesuai di dalam Formularium atau obat yang dibutuhkan tidak ada dalam daftar Formularium Nasional. Ketidaksesuaian peresepan obat yang disebabkan karena penerapan Formularium Nasional sebagai pedoman pengobatan belum baik akan berpengaruh pada mutu pelayanan dan biaya pengobatan. Resep yang tidak sesuai

dengan Formularium Nasional tidak di layani karena obatnya tidak tersedia dan obat tidak termasuk dalam biaya pengobatan. Dari data tersebut bahwa tingkat kesesuaian peresepan obat pasien BPJS Rawat Jalan belum sesuai indikator berdasarkan Formularium Nasional 100%.

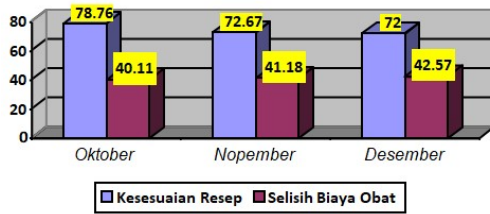
b. Peresepan Obat dan Selisih Biaya Obat

Selisih biaya obat adalah biaya obat di luar Formularium Nasional yang merupakan biaya tambahan bagi rumah sakit karena di luar paket pengobatan dan tidak dapat ditagihkan tersendiri. Hasil prosentase selisih biaya obat diluar Formularium Nasional yang didapat antara rentang antara 40% - 43%. Nilai rata-rata prosentase selisih biaya adalah 41,38%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa biaya obat diluar paket biaya pengobatan masih cukup besar, dengan nilai tingkat kesesuaian peresepan terhadap Formularium Nasional sebesar 74,48%. Artinya tingkat kesesuaian peresepan obat terhadap Formularium Nasional mempengaruhi efisiensi biaya obat.

Tabel 4. Perhitungan Selisih Biaya Obat Pasien BPJS Rawat Jalan

Bulan	Jumlah Resep	Biaya Obat Fornas (Rp.)	Biaya Obat diluar Fornas (Rp.)	Total Biaya (Rp.)	Selisih Biaya (%)
Oktober	134	2.167.814	1.719.900	4.287.843	40,11%
Nopember	125	2.567.943	1.897.942	4.575.440	41,48%
Desember	141	2.677.498	1.607.360	3.775.174	42,57%
Rata-rata					41,38%

Upaya yang dilakukan Instalasi Farmasi dalam rangka pengendalian biaya obat adalah dengan pemberian jumlah obat sesuai restriksi yang terdapat pada Formularium Nasional. Restriksi adalah pemberian jumlah obat maksimal sesuai aturan dalam Formularium Nasional. Pada penelitian yang serupa di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (Charlie dkk., 2017) upaya pengendalian biaya dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan telaah resep pada pasien BPJS rawat jalan. Melakukan intervensi oleh apoteker untuk meningkatkan rasionalisme sekaligus efisiensi biaya. Intervensi yang di lakukan apoteker di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah penggantian obat, perubahan frekuensi, perubahan bentuk sediaan, pembatasan jumlah, pembatalan terapi, penyesuaian dosis.



Gambar 1. Prosentase Kesesuaian Peresepan Obat terhadap Biaya Obat Tahun 2018

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian peresepan paling tinggi pada bulan Desember sebesar 78,76% dan nilai selisih biaya terendah sebesar 40,11%. Sedangkan tingkat kesesuaian peresepan terendah pada bulan November sebesar 72,00% dan nilai selisih biaya terbesar sebesar 42,57%. Dari data di bawah ini dapat diketahui bahwa kesesuaian peresepan mempunyai hubungan dengan selisih biaya.

4. Analisa Bivariat

Pada penelitian ini pengolahan data menggunakan Uji Korelasi *Spearman* untuk mengetahui tingkat kesesuaian peresepan berdasarkan Formularium Nasional dan hubungan antara kesesuaian peresepan dan kendali biaya pada pasien BPJS Rawat Jalan di RSUD Ungaran

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi *Spearman*
Correlations

	resep	biaya
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1,000
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	400
	biaya	Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
		400

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan pada uji Korelasi *Spearman* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan signifikan yang sangat kuat dan berlawanan arah antara variabel kesesuaian resep terhadap selisih biaya.

KESIMPULAN

Tingkat kesesuaian peresepan obat berdasarkan Formularium Nasional pada pasien BPJS Rawat Jalan di RSUD Ungaran 74,48% yang artinya belum sesuai dengan indikator berdasarkan Formularium Nasional bahwa kesesuaian peresepan berdasarkan formularium 100%. Besarnya selisih biaya

obat di luar Formularium Nasional rata-rata adalah 41,38 % setiap bulannya Rp. 1.741.734. Berdasarkan pada uji Korelasi *Spearman* bahwa ada hubungan bermakna yang sangat kuat dan berlawanan arah antara variabel kesesuaian resep terhadap selisih biaya.

Usulan perbaikan pelayanan kefarmasian pada pasien BPJS Rawat Jalan dengan penerbitan kebijakan oleh pihak manajemen Rumah Sakit yang mengatur tentang pedoman pelayanan pasien BPJS Rawat Jalan, ketersediaan obat sesuai Formularium Nasional di Instalasi Farmasi, peresepan obat di luar Formularium Nasional pasien BPJS Rawat Jalan dan adanya evaluasi pelayanan kefarmasian pasien BPJS Rawat Jalan secara berkala yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan efisiensi biaya pengobatan pasien terutama pada pasien BPJS Rawat Jalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Medisa, Dian, 2015, *Kesesuaian Resep Dengan Standar Pelayanan Medis Dan Formularium Jamkesmas Pada Pasien Rawat Jalan Jamkesmas*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mendrofa, Devina Eirene, Chriswardani Suryawati, 2016, *Analisis Pengelolaan Obat Pasien BPJS Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Nurlela, Bustami dan Bastian, 2010, *Akuntansi Biaya. Edisi kedua*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Pratiwi, Winda Ratna, Angga P.K and Dolih Gozali, 2017, *Hubungan kesesuaian penulisan resep dengan Formularium*

- Nasional terhadap mutu pelayanan pada pasien jaminan kesehatan nasional di Rumah Sakit umum di Bandung*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Punaji, Setyosari, 2010, *Metode Penelitian Penelitian dan Pengembangan*, Kencana, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2004.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 2011.
- World Health Organization, 1988, Estimating drugs requirement dalam A practical manual. Geneva, WHO press.
- Yusuf, A. Muri, 2005, *Metodologi Penelitian (Dasar – Dasar Penyelidikan Ilmiah)*. Padang, UNP Press.